

表2 アレルギー関連の呼吸器疾患で実施する主な免疫学的検査（水色は原因アレルゲンを特定するための検査）

項目	気管支喘息	過敏性肺炎	好酸球性肺炎	EGPA	ABPM	薬剤性肺炎
総IgE値	○		△ (上昇例あり)	○	○	
特異的IgE抗体	○				○	
皮膚テスト	△				○	△
特異的IgG抗体		○		(ANCA)	○	
リンパ球幼若化試験		○ (末梢血/気管支肺胞洗浄液)				○
アレルゲン誘発試験	△ (実施はまれ)	○				△ (偶発の再投与)
アレルゲン除去試験		○				
その他		気管支肺胞洗浄 (環境調査)	△ (組織診)	△ (組織診)	喀痰真菌培養 気管支鏡下 粘液栓中真菌同定	△ (組織診)

EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、ABPM：アレルギー性気管支肺真菌症。

として重要であるが、原因アレルゲンの同定に向けては、血中特異的IgE抗体の測定が実施される。当初の測定法が放射性同位元素を標識物質として利用した放射性アレルゲン吸着法（radioallergosorbent test：RAST）であったため、現在でもその名称で呼ばれることが多いが、正しくは免疫測定法（immunoassay）に包括されるものであり、現在汎用されているのは、蛍光酵素免疫測定法（fluorescence enzyme immunoassay：FEIA）によるImmunoCAP法である。

b 皮膚テスト

原因アレルゲン特定の信頼度においては皮膚テストが特異的IgE抗体の測定に勝るため、ブリックテスト（>スクラッチテスト）は広く実施されている。試薬は鳥居薬品のアレルゲン製品（診断用スクラッチエキス）と公益財団法人日本アレルギー協会を介した輸入アレルゲンエキス（ALK Abello社製品）がある。皮内テストは、個人差により皮膚の反応が弱いためにブリックテストにおいて陽性対照のヒスタミンでもほとんど膨疹が生じない場合や、被疑物質が原因アレルゲ

ンとして疑わしいにもかかわらずブリックテストが陰性の場合に実施する。皮内テストは感度が高い反面、アレルギー症状の誘発や偽陽性の確率も高いためルーチンでは実施されない。

c その他の免疫学的検査

夏型過敏性肺炎の原因真菌として重要なトリコスポロン・アサヒ（*Trichosporon asahii*）抗体の測定にはantigen-captured ELISA法が用いられる。アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の診断に用いられるアスペルギルス抗体はオクタロニー法で測定される。またImmunoCAP法でアスペルギルスの特異的IgE抗体陽性を示す。アスペルギルス・フミガーツス由来のアレルゲンコンポーネントのひとつであるAspf1も測定可能となった。その他カンジダ、ムコールなども測定できる。IV型アレルギーの機序による薬剤性肺障害において、リンパ球幼若化試験（DLST）が実施されるが、副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬、抗腫瘍薬が使用されている場合は偽陰性になりやすい。